

Suivi biologique d'une MRC / IRC

ESMS | Fréquence guidée par DFG + albuminurie, pas seulement par le stade

Lecture de la grille KDIGO

- **G1 à G5** = catégories de DFG (stades de fonction rénale) : G1 ≥ 90 ; G2 60-89; G3a 45-59; G3b 30-44; G4 15-29; G5 < 15 mL/min/1,73 m².
- **A1 à A3** = catégories d'albuminurie selon le RAC. Le nombre dans la grille = fréquence indicative de contrôle par an.

Grille de fréquence indicative - DFG / RAC

Catégorie DFG	A1 < 3 mg/mmol	A2 3-29	A3 ≥ 30
G1 ≥ 90	1/an*	1/an	3/an
G2 60-89	1/an*	1/an	3/an
G3a 45-59	1/an	2/an	3/an
G3b 30-44	2/an	3/an	3/an
G4 15-29	3/an	3/an	≥ 4 /an
G5 < 15	≥ 4 /an	≥ 4 /an	≥ 4 /an

Ordonnance de base MRC

- **Créatinine + DFG CKD-EPI**
- **RAC urinaire**
- **Na, K**
- **Bicarbonates** si G3b-G5 ou risque d'acidose
- **NFS** si G3b-G5 ou suspicion d'anémie

Complications - seulement si stade / risque pertinent

- **Ferritine + CST** si anémie/MRC avancée.
- **Calcémie, phosphorémie, PTH, PAL** selon stade G3b-G5, anomalies antérieures et prise en charge CKD-MBD.
- **Albuminémie** si risque nutritionnel; CRP si contexte inflammatoire/interprétation.

25-OH vitamine D - remboursement

- Ne pas intégrer au bilan MRC de routine.
- La MRC/IRC seule n'est pas une indication de remboursement.
- Indication NABM spécifique : suivi ambulatoire de l'adulte transplanté rénal au-delà de 3 mois, ou l'une des 5 autres situations limitatives.
- Hors cadre : mention "NR".

Repère

- * G1-G2 A1 : sans autre marqueur de lésion rénale, ne définit pas une MRC.
- Adapter la fréquence à la vitesse d'évolution, aux traitements (IEC/ARA2, iSGLT2, ARM), au potassium et au projet de soins.